

Obstrucción de vía aérea superior

1. Introducción y relevancia clínica

La **obstrucción de la vía aérea superior (OVAS)** constituye una de las **emergencias más graves en ORL**, ya que puede llevar a **hipoxia cerebral y paro cardiorrespiratorio** en pocos minutos.

Se define como la **interrupción parcial o total del flujo de aire** por compromiso de la **nariz, faringe, laringe o tráquea proximal**.

Relevancia clínica

- Es una urgencia **tiempo-dependiente**: el reconocimiento precoz salva vidas.
- La etiología es **multifactorial**, destacando causas inflamatorias, traumáticas, tumorales y cuerpos extraños.
- En APS, el enfoque clave es **identificar signos de obstrucción y asegurar la vía aérea antes de derivar**.

Epidemiología

- Más frecuente en **niños menores de 5 años** (crup, epiglotitis, cuerpo extraño).
- En adultos, predomina por **tumores, abscesos faríngeos o trauma**.
- En Chile, representa cerca del **2% de las consultas de urgencia ORL**, siendo una de las principales causas de **mortalidad prehospitalaria evitable**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional de la vía aérea superior

La vía aérea superior comprende:

- **Nariz y nasofaringe**
- **Orofaringe**

- **Laringe**
- **Tráquea proximal**

La obstrucción en cualquiera de estos niveles produce **alteración del intercambio gaseoso**, generando **hipoxia**, **retención de CO₂** y eventualmente **acidosis respiratoria**.

2.2 Mecanismos fisiopatológicos

La obstrucción puede ser:

- **Mecánica:** cuerpo extraño, tumor, absceso, edema o colapso dinámico.
- **Inflamatoria:** infecciones agudas (epiglotitis, laringitis, angioedema).
- **Neuromuscular:** parálisis bilateral de cuerdas vocales.
- **Traumática:** fractura laríngea, hematoma post intubación.

El grado de obstrucción determinará la severidad clínica:

- **Parcial:** estridor, dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios.
 - **Completa:** silencio respiratorio, cianosis, pérdida de conciencia.
-

2.3 Compensación fisiológica

Inicialmente el paciente aumenta:

- **Frecuencia respiratoria y trabajo respiratorio.**
- **Uso de músculos accesorios.**

Luego, si no se resuelve:

- Aparece **fatiga respiratoria**, **hipoxia severa** y **colapso circulatorio**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas generales

- **Disnea progresiva o súbita.**
- **Estridor** (ruido agudo audible durante la respiración):
 - **Inspiratorio:** obstrucción supraglótica (epiglotis, faringe).
 - **Espiratorio:** obstrucción traqueal.
 - **Bifásico:** obstrucción glótica o subglótica.
- **Tiraje intercostal, supraesternal o subcostal.**
- **Cianosis o hipoxemia.**
- **Tos, disfonía o afonía.**
- **Ansiedad, agitación o somnolencia.**

□ En niños, el estridor y el uso de músculos accesorios son los signos más precoces de OVAS.

3.2 Diagnóstico diferencial según etiología

Grupo etiológico	Causas más frecuentes	Edad típica	Hallazgos claves
Infeccioso	Crup, epiglotitis, absceso retrofaríngeo, amigdalitis obstructiva	Niños	Fiebre, estridor, dificultad respiratoria
Alérgico / inmunológico	Angioedema, anafilaxia	Todas las edades	Edema facial, urticaria, prurito, antecedente alérgico
Traumático	Fractura laríngea, hematoma cervical, cuerpo extraño	Jóvenes, adultos	Disfonía, enfisema subcutáneo, antecedente de trauma

Tumoral	Carcinoma laríngeo, masas faríngeas	Adultos mayores	Disfonía progresiva, disfagia, pérdida de peso
Neurológico	Parálisis bilateral de cuerdas vocales	Adultos	Voz soplada, estridor, sin fiebre

3.3 Evaluación inicial

Evaluar siempre signos de alarma:

1. Estridor audible sin estetoscopio.
2. Tiraje supraclavicular o intercostal.
3. Dificultad para hablar o tragar saliva.
4. Cianosis o saturación <90%.
5. Alteración del nivel de conciencia.

Todo paciente con alguno de estos signos requiere **intervención inmediata para asegurar vía aérea**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **fundamentalmente clínico**, basado en:

- Presencia de estridor o disnea aguda.
 - Evidencia de obstrucción parcial o total.
 - Antecedentes recientes de infección, alergia, trauma o ingesta de cuerpo extraño.
-

4.2 Exámenes complementarios (una vez asegurada la vía aérea)

A – Airway (vía aérea) - Posicionar al paciente sentado o semisentado.- Administrar O₂ con FiO₂ alta.- Evitar agitación (aumenta el edema).

B – Breathing - Evaluar patrón respiratorio y saturación.- Preparar equipo de intubación.

C – Circulation - Canalizar vía venosa periférica.- Reposición de líquidos si hipotenso.

En obstrucción completa: **maniobra de Heimlich** si cuerpo extraño visible o sospechado.
En niños: 5 golpes interescapulares alternados con 5 compresiones torácicas.

5.3 Manejo específico según causa

1. Crup (laringotraqueobronquitis viral)

- Oxígeno humidificado.
 - **Dexametasona 0,15 mg/kg VO o IM (máx. 8 mg).**
 - **Adrenalina racémica nebulizada** si estridor en reposo.
 - No intubar a menos que haya fatiga respiratoria.
-

2. Epiglotitis (emergencia vital)

- **No examinar con bajalenguas (riesgo de laringoespasma).**
 - Asegurar vía aérea en pabellón (intubación bajo visión directa).
 - **Ceftriaxona 50 mg/kg/día IV.**
 - **Dexametasona IV.**
-

3. Angioedema o anafilaxia

- **Adrenalina IM (0,01 mg/kg, máx. 0,5 mg, repetir cada 5–15 min).**

- **O₂ + suero fisiológico IV.**
 - **Corticoides IV (hidrocortisona 100 mg o dexametasona 8 mg).**
 - **Antihistamínicos IV.**
 - Si edema glótico → intubación o cricotiroidotomía de urgencia.
-

4. Cuerpo extraño

- **Maniobra de Heimlich o RCP** si obstrucción completa.
 - **Laringoscopia directa / broncoscopia rígida** bajo anestesia general para extracción.
 - Posterior observación 24 h con corticoides.
-

5. Absceso retrofaríngeo o periamigdalino

- **Antibióticos IV (ampicilina-sulbactam o clindamicina).**
 - **Drenaje quirúrgico** si colección evidente.
 - Corticoides para reducir edema.
-

6. Tumores laríngeos o faríngeos

- Asegurar vía aérea con **intubación o traqueostomía.**
 - Derivación a ORL oncológico.
-

5.4 Intubación o cricotiroidotomía

Si el paciente presenta:

- Estridor severo, cianosis, SpO₂ < 90% pese a O₂ .

- Fatiga respiratoria o somnolencia.
- Obstrucción progresiva.

Opciones:

1. **Intubación orotraqueal** (preferida si es posible).
 2. **Cricotiroidotomía de emergencia:**
 - Técnica rápida, indicada cuando la intubación es imposible.
 - Se realiza entre el cartílago tiroides y cricoides.
 3. **Traqueostomía quirúrgica:**
 - Definitiva, indicada en obstrucciones altas o crónicas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

- Hipoxia y daño neurológico irreversible.
 - Paro cardiorrespiratorio.
 - Neumotórax o enfisema subcutáneo post intubación.
 - Infecciones secundarias (neumonía, sepsis).
 - Estenosis laríngea post cricotiroidotomía prolongada.
-

6.2 Pronóstico

- Depende de la **causa y rapidez del manejo**.
- Si se asegura la vía aérea precozmente → mortalidad <2%.
- En epiglotitis o anafilaxia no tratadas → mortalidad >20%.

- Mejor pronóstico en pacientes sin hipoxia prolongada.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Estridor = signo de obstrucción significativa.**
 2. **No examinar orofaringe** en sospecha de epiglotitis (puede precipitar paro respiratorio).
 3. **Siempre asegurar vía aérea antes de buscar la causa.**
 4. **Cricotiroidotomía salva vidas** si intubación no es posible.
 5. **Adrenalina nebulizada y corticoides** son pilares en causas inflamatorias.
 6. **Cuerpo extraño traqueal o laríngeo** → extracción bajo visión directa.
 7. **Derivación inmediata a ORL o pabellón** si compromiso inminente.
-

Errores comunes

- Intentar múltiples intubaciones sin oxigenar.
 - Enfocar el tratamiento etiológico sin estabilizar primero.
 - No tener disponible equipo de vía aérea difícil.
 - Omitir observación post evento (riesgo de edema rebote).
 - Subestimar estridor leve en niños (puede evolucionar a obstrucción total).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **obstrucción de vía aérea superior (OVAS)** es una urgencia vital que requiere acción inmediata.

2. **Signos clave:** estridor, disnea, uso de músculos accesorios y cianosis.
3. **Prioridad:** asegurar oxigenación antes de investigar la causa.
4. **Tratamiento específico** según etiología: infección, alergia, trauma o cuerpo extraño.
5. En obstrucción grave → **intubación o cricotiroidotomía de urgencia.**
6. No manipular orofaringe si se sospecha **epiglotitis.**
7. Pronóstico excelente si el manejo es precoz y adecuado.